psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIA

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Cristian Undurraga
R.U.T. : 27.300.905-1
Fecha de Nacimiento / edad : 25/06/2020 / 5 años
Nivel escolar : Prekinder
Establecimiento escolar : Colegio San Miguel Arcángel, Las Condes.

II.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Silvina García. (2012). *Protocolo para la evaluación de la pragmática del lenguaje infantil*. Buenos Aires: material clínico de evaluación del lenguaje.
- Prutting, C. A., & Kirchner, D. M. (1987). *Pragmatic Protocol*. Basado en: A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 52, 105–119.
- Protocolo de elaboración propia para evaluar habilidades lingüísticas.
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Escala de juego de Susan Knox.
- Matriz de comunicación.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Cristian durante el proceso de reevaluación logra adecuarse al espacio con apoyos principalmente de entrada, donde logra participar de forma activa cuando el espacio es estructurado y adecuado. Cabe mencionar que frente a dificultades durante la realización de actividades tiende a lanzar los objetos que se encuentran frente a él.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

Áreas	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión	59		
Audición	52		
Tacto		61	
Conciencia Corporal		61	
Equilibrio y movimiento	54		
Planificación e ideas		67	
Participación social			70

Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular *Vías evaluadas: vestíbulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestíbulo-cerebelosas*	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) **(10 rotaciones en 20 segundos)** **Respuesta entregada:** no pesquisado, Florencia no se pudo habituar a esta prueba. **1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal:** Dificultad en extensión de tronco y cuello. Inconsistente. **2.-Reacciones de protección:** Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. Posiciona mano-muñeca. **3.-Reacciones de equilibrio:** **3.1 Reactivas:** Inconsistente. **3.2 Anticipatorias**: Inconsistente **4.-Coordinación ocular:** **4.1.-Seguimiento ocular:** Inconsistente al combinar en diferentes planos anatómicos y demandas mayores. **4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza:** Inconsistente compensa con rigidez de cuello. **5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad:** **5.1.- Coordinación bii:** Inconsistente. **5.2.- Lateralidad:** Inconsistente. **6.- Feedforward:** Inconsistente. **7.- Respuesta al movimiento:** Rotación con desafíos, se intensifica nivel de alerta. Lineales logrado.	**1.-Alineación de articulaciones:** Inconsistente aislados/combinados, compensa con aumento en la base de sustentación de EE.II. **Talón a punta del pie**: Inconsistente. **Extensión de brazos Schiller:** No logra recepcionar estimulo sin apoyo visual. **2.- Tono muscular:** Acorde. **3.-Control postural:** Inconsistente, desafíos para el control abdominal. **4.- Planeamiento motor:** Inconsistente, actividades simples lograda. **Skipping:** Inconsistente **Jumping Jacks:** No logrado, desafíos para la sincronización.	**1.-Registro:** **1.1.- Registra sin ver:** inconsistente. **1.2.-Se quita elementos sin ver:** Logrado. **2.-Modulación:** **2.1.-Copia 2D:** Inconsistente, desafíos para el cruce de línea media. **2.2.-Copia 3D:** no logrado **2.3.-Copia con el cuerpo:** **-EE.SS:** Inconsistente **-EE.II: I**nconsistent**e** **-Combinado:** No logrado. **3.-Discriminación:** **3.1.-Desafíos finos:** Desafíos para el entrenamiento de pinzas y agarres esperadas para su edad cronológica, compensa con agarre cilíndrico. **3.1.-Dificultades oro-faciales:** dificultad en cierre labial. **3.2.- Orden de su espacio:** no logrado.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE.

Actividad	Edad
Alimentación	No cumple actividades según su edad cronológica
Vestuario	No cumple actividades según su edad cronológica
Higiene	Cumple ctividades según su edad cronológica
Autocuidado	No cumple actividades según su edad cronológica

Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	1+4+1+1	7/16
Habituación	4+2+4+3	13/16
Habilidades de comunicación	4+1+1+1	7/16
Habilidades de procesamiento	3+3+4+2	12/16
Habilidades motoras	4+2+3+4	13/16
Ambiente	4+4+4+4+4	20/20
Total		67/100

Escala de juego de Susan Knox.

Dimensiones y factores	Edades en meses	Dimensiones y factores	Edades en meses
1 Manejo del espacio	**48+36=84:2=42**	**3 Simulación/simbolismo**	**36+24=60:2=30**
1.1 Motricidad gruesa	48	**3.1 Imitación**	36
1.2 Interés	36	**3.2 Dramatización**	24
2 Manejo de materiales	**36+48+36+36=156:4=39**	**4 Participación**	**36+30+30+24=120:4=30**
2.1 Manipulación	36	**4.1 Tipo**	36
2.3 Construcción	48	**4.2 Cooperación**	30
2.4 Propósito	36	**4.3 Humor**	30
2.4 Atención	36	**4.4 Lenguaje**	24
Edad del desarrollo del juego	42+39+30+30=156:4=39 **3 años con 3 meses**		

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

Matriz de comunicación

Nivel 1 Comportamiento preintencional	A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa comodidad						A3 Muestra interés en otras personas									
Nivel 2 Comportamiento intencional	B1 Protestas	B2 Acción continua		B3 Obtiene más de algo				B4 Atrae la atención									
Nivel 3 Comunicación no convencional	C1 Se niega, rechaza	C2 Solicita más acciones	C3 Solicita Nueva Acción	C4 Solicita más objeto	C5 Toma decisiones	C6 Solicita un nuevo objeto		C8 Solicita atención	C9 Muestra afecto								
Nivel 4 Comunicación convencional	C1 Se niega, rechaza	C2 Solicita más acciones	C3 Solicita Nueva Acción	C4 Solicita más objeto	C5 Toma decisiones	C6 Solicita un nuevo objeto		C8 Solicita atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a la gente	C11 Ofertas, acciones	C12 Dirige tu atención	C13 Formas sociales educadas	C14 Respuestas a preguntas sí/no	C15 Hace preguntas		
Nivel 5 Símbolos concretos	C1 Se niega, rechaza	C2 Solicita más acciones	C3 Solicita Nueva Acción	C4 Solicita más objeto	C5 Toma decisiones	C6 Solicita un nuevo objeto	C7 Peticiones Objetos Ausentes	C8 Solicita atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a la gente	C11 Ofertas, acciones	C12 Dirige tu atención	C13 Formas sociales educadas	C14 Respuestas a preguntas sí/no	C15 Hace preguntas	C16 Nombres Cosas/ Personas	C17 Hace comentarios
Nivel 6 Símbolos abstractos	C1 Se niega, rechaza	C2 Solicita más acciones	C3 Solicita Nueva Acción	C4 Solicita más objeto	C5 Toma decisiones	C6 Solicita un nuevo objeto	C7 Peticiones Objetos Ausentes	C8 Solicita atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a la gente	C11 Ofertas, acciones	C12 Dirige tu atención	C13 Formas sociales educadas	C14 Respuestas a preguntas sí/no	C15 Hace preguntas	C16 Nombres Cosas/ Personas	C17 Hace comentarios
Nivel 7 Idioma	C1 Se niega, rechaza	C2 Solicita más acciones	C3 Solicita Nueva Acción	C4 Solicita más objeto	C5 Toma decisiones	C6 Solicita un nuevo objeto	C7 Peticiones Objetos Ausentes	C8 Solicita atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a la gente	C11 Ofertas, acciones	C12 Dirige tu atención	C13 Formas sociales educadas	C14 Respuestas a preguntas sí/no	C15 Hace preguntas	C16 Nombres Cosas/ Personas	C17 Hace comentarios
	Rechazo	Obtener						Social						Información			

- No utilizado
- Emergentes
- Dominado
- Superado

III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa: Cristian durante el periodo de intervención se observan un mayor control abdominal en sedente, lo cual le ha permitido mayor visualización de materiales y focalización en objetivos. Por otro lado, se pesquisa una participación en patrones de movimiento nuevos donde necesita de un modelamiento y apoyo físico ocasional. **A nivel de disociación de extremidades** en actividades y espacios libres se observa mayor conciencia corporal frecuentemente.

A nivel de actividades de retroalimentación (feedback) logra juegos de pelotas simples con otro, donde dichos juegos deben ser de menor tiempo, pero mayor demanda, logrando adecuarse. Cabe mencionar que el desempeño de Cristian va de la mano con el nivel de alerta basal, necesitando frecuentemente actividades de activación previa. **A nivel de actividades de ensayo y error (feedforward**) se observan desafíos desde la tolerancia a la frustración donde frente al primer error se observan conductas disruptivas; necesitando apoyo para realizar reparos (recoger y/o guardar) y continuar.

A nivel de planeamiento motor se siguen observando desafíos, donde mediante la sistematización de patrones de movimiento y actividades de acción-atención conjunta Cristian logra replicar y/o realizar movimientos presentados por medio del juego.

Para finalizar es correcto señalar que Cristian *necesita de un modelado y apoyo físico ocasional* para lograr reconocer y procesar patrones de movimientos no conocidos ya que, frente a solicitudes directas sin apoyos, tiende a abandonar el espacio.

1.2.- Motricidad fina:

En primera instancia Cristian logra Consolidar la realizar de pinzas y agarres esperados para su edad cronológica actual, donde al utilizar en actividades funcionales/rutinarias tiende a perder la posición biomecánica del segmento muñecas mano. Por otro lado, se observa mayor calibración de fuerza en la utilización de cepillo de dientes y utensilios para alimentación.

A nivel de coordinación ojo mano, Cristian logra realizar la secuencia sin perder el foco de atención cuando se encuentra en espacios con menor numero de estímulos, logrando objetivos planteados. Cabe mencionar que para potenciar dicha secuencia Cristian necesita de apoyo fisio y verbal para su mantención.

A nivel de control motor de lápiz, Cristian logra rasgar, marcar, tirar cuando se entrega un apoyo verbal-visual ya que tiende a distraerse con objetos cercanos a él. En relación con trazos, Cristian logra consolidar trazos rectos sin apoyo; se continúan consolidando trazos curvos y mixtos. Cabe mencionar que Cristian logra la copia de figuras básicas circulo, cruz y cuadro con un modelado inicial.

2.- <u>Desarrollo Cognitivo</u>:
Es correcto señalar que desde el área cognitiva se observan desafíos para la consolidación de habilidades cognitivas, donde frente a la estimulación y trabajo sistematizado se observan cambios significativos en el desempeño. A continuación, se describen áreas evaluadas:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:
Cristian en primera instancia logra mantenerse focalizado en actividades por periodos de 10-15 minutos cuando el espacio sistematizado, logrando replicar la cuando a seguir, por ejemplo: Busco colores en SCAA-busco pompon- busco donde colocar pompon.

Cabe mencionar que en espacios con mayor numero de estímulos y actividades semiestructuradas necesita de mayor apoyo para lograr a focalización. Dentro de las estrategias utilizadas para potenciar la atencion se encuentran las adecuaciones de entrada para la información y tiempos de descansos estructurados para la autorregulación.

Cabe mencionar que en actividades de atencion diferida, Cristian necesita de apoyo para mantener la coordinación ocular y movimiento motor.

2.2.-Procesos básicos de secuenciación:
En primera instancia Cristian con material concreto logra de hacer secuencias de hasta 3 elementos cuando se entrega un modelamiento inicial. Desde la secuenciación de tareas para una actividad Cristian logra reconocer la secuencia, pero tiende a distraerse con estímulos de fondo necesitando de apoyo verbal para mantenerse de forma independiente en rutina y actividades de su espertis.

2.3.-Procesos básicos percepción visual:
Cristian logra identificar estímulos visuales con colores y márgenes delimitados, donde busca a mirada del adulto para solicitar ayuda y continuar participando e actividades. Cristian logra utilizar material terapéutico de figura-sobra y figura-fondo. Se observan algunos desafíos para lograr participar en actividades visomotoras de mayor complejidad.

2.4.- Funciones ejecutivas:

2.4.1.- Velocidad de procesamiento:
Se observa que Cristian frente actividades conocidas y/o de su espertis logra la entrega de respuesta motora en periodos menores, donde al aumentar la complejidad necesita de algunos segundos extra para lograr procesar la información entregada por el contexto y adulto. Cabe mencionar que dichos periodos extra deben ser entregados para evitar el escalamiento de la conducta.

2.4.2.- Flexibilidad cognitiva:
Se pesquisa que debido a diagnostico de base Cristian necesita de apoyo para lograr ceder frente a demandas tanto sociales y cognitivas; donde se utiliza la estrategia de realizar pequeños cambios de forma diaria y realizar sesiones con el mismo material, pero diferente objetivo, donde en ocasiones bota objetos presentados y abandonando el especio. De igual forma con el apoyo desde el modelamiento logra volver a adecuarse al espacio.

2.4.3.- Control Inhibitorio:
Cristian presenta desafíos significativos desde la presente área, ya que necesita de contextos sistematizados ara lograr estructurar su conducta y potenciar la conducta adaptativa; ya que sin dicho apoyo los tiempos de espera y respeto de turnos se vuelven un desafío.

3.- <u>Desarrollo Comunicación y Lenguaje</u>

III.1 Etapa lingüística:

III.1.1 **Exploración sistema estomatognático:**
En relación con las estructuras anatómicas del habla observadas, se aprecia que Cristian presenta mejillas simétricas, labios de tamaño, color y funcionalidad normal, se observa cierre labial en reposo y con esfuerzo. Presenta frenillo sublingual con movilidad adecuada para ejercer deglución y habla correctamente, lengua de tamaño, color normal, úvula presente y dentición en etapa temporal.

III.1.2 **Funciones prearticulatorias:**
Respecto al modo y tipo respiratorio estos son nasal y abdominal por lo que se encuentra adecuado ya que el aire ingresa por vía nasal y se acumula en zona abdominal. El soplo se encuentra presente con adecuada dirección y presión reducida. Deglución normal sin hallazgos patológicos.

III.1.3 **Nivel fonético y fonológico:**

En relación con el nivel fonético de Cristian, este se encuentra limitado debido a factores neuromotores (Apraxia del habla infantil), sin embargo, se encuentra adquirido el fonema /m/ y /p/ en sílabas con vocales abiertas.

A nivel fonológico no produce palabras de larga metría (bisilábicas, trisilábicas, polisilábicas) emitiendo solo “mamá” y “papá” con ayuda visual o verbal. En relación con la repetición de sílabas, Cristian no logra por factores como estímulos ambientales, tipos de apoyo o estado conductual. Los errores que presenta son de tipo consistente por lo que en todas las palabras independientemente de la composición de esta y la posición del sonido, no lo genera.

III.1.4 **Nivel léxico semántico:**

A nivel semántico comprensivo, Cristian logra identificar elementos de categorías semánticas básicas (animales de la granja, selva, insectos, frutas, verduras y colores), también identifica con apoyo, categorías semánticas complejas (instrumentos, artículos de higiene, artículos escolares, medios de transporte) también identifica con apoyo, elementos por atributo. También clasifica mediante pareo visual, asocia auditivamente y relaciona semánticamente elementos de la misma categoría. No identifica absurdos visuales ni verbales, semejanzas y diferencias.

En cuanto a la expresión de elementos, mediante el contexto se logra la comprensión. Por otro lado, presenta dificultades en la expresión verbal, evocación, definición, nominación de elementos básicos o complejos.

III.1.5 **Nivel morfosintáctico:**

A nivel morfosintáctico comprensivo, comprende instrucciones de baja y alta complejidad, la ejecución la realiza dependiendo del estado de atención y estímulos ambientales. Identifica preposiciones de lugar (arriba - abajo) con apoyos verbales, reconoce elementos según género.

A nivel expresivo Cristian no logra evocar, definir o nominar elementos gramaticales.

III.1.6 **Nivel pragmático:**

A nivel de aspectos verbales, Cristian posee intención comunicativa, expresa cuando necesita algo, cuando necesita ir al baño, comer o tomar agua. Realiza preguntas de forma ecolálica que se deben redirigir.

En cuanto a parámetros no verbales, Cristian emplea deícticos al momento de solicitar objetos de su interés, el contacto visual suele ser por un tiempo determinado generalmente dependiente de los estímulos ambientales y estado conductual. En relación con la proxémica (distancia corporal) regularmente se mantiene adecuada, sin embargo, cuando se siente feliz o aumenta la demanda, se acerca o sienta sobre las terapeutas. Presenta una postura corporal adecuada, con movimientos deambulantes regulatorios. En cuanto a las expresiones faciales, se logra identificar cómo se siente, sin embargo, esta se mantiene monótona.
Por último, en los parámetros paralingüísticos, se visualiza que: fluidez, inteligibilidad y prosodia se encuentran severamente alteradas.

4.- <u>Desarrollo socioemocional</u>.

4.1.-Tipo de juego:

Cristian presenta una preferencia por un juego sensorio motor. Se observa un inicio de interés por juguetes simbólicos donde con apoyo del adulto logra realizar acciones convencionales. Cabe mencionar que desde el inicio del proceso de intervención Cristian demuestra mayor flexibilidad para mantenerse en juegos que no so de su interés e interactuar con el adulto.

4.2.-Interacción social:

4.2.1.-Interacciòn social con adultos:

Cristian logra reconocer jerarquías de niño-adulto, donde busca a este para satisfacer necesidades basicas y de contención emocional. Cabe mencionar que frente a límites de espacios y utilización de objetos de interés necesita de anticipación visual-verbal para lograr ceder frente a demandas. Solo de forma ocasional se observan conductas disruptivas frene a limites.

4.2.2.-Interacciòn social con pares:

Cristian logra mantenerse en los mismos espacios y actividades que sus pares, donde al entregar apoyo para tarea colaborativas inicia de forma ocasional interacciones sociales.

5.- <u>Procesamiento sensorial y conducta</u>

Según instrumentos de evaluación SPM Hogar-Escolar y observación clínica de procesamiento sensorial, se puede analizar que Cristian presenta desafíos para la modulación de estímulos sensoriales, lo cual es proyectado por medio de conductas desadaptativas, las cuales al no ser modeladas y apoyas escalan a conductas disruptivas frente a pares y adultos. A continuación, se describen como los desafíos sensoriales son proyectados a nivel de conducta:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos de modulación.	-Prefiere comer con sus manos. -Tiende a movilizar su cuerpo con movimiento oscilantes. -Mira “menos” al adulto. -Desafíos en conducta. -Se sienta con piernas dobladas en w. -Dificultades en tiempos de actividades de la vida diaria. -Nivel de alerta inconsistente. -“Pareciera aburrido”.
Propioceptivo	Sobre uso propioceptivo.	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Moviliza su cuerpo frente a demandas. Busca la autorregulación. -Desafíos para el reconocimiento de actividades de riesgo. -Participa en actividades donde debe empujar, arrastrar, levantar y saltar. -“Contorsiona” su cuerpo en espacios con mayor número de estímulos.
Táctil	Hiporespuesta, desafíos para la modulación estímulos sensoriales.	-Prefiere mirar antes que hacer. -Explora objetos nuevos de forma oral. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos. -Manipula siempre los mismos objetos. -Desafíos para la atención y acción conjunta. -Dificultades para encontrar objetos sin visión (discriminación táctil). -Desafíos el inicio de entrenamiento motor de lápiz. -En actividades de mayor demanda tiende a subir su nivel de alerta.
Visual/Auditivo	Hiporespuesta, desafios en la modulación y discriminación de estímulos sensoriales.	-Se distrae con estímulos de fondo en los diferentes ambientes. -En actividades con mayor cantidad de estímulos visuales tiende a rayar. -Pareciera no seguir instrucciones. -Respuesta al nombre inconsistente. -Reconoce objetos mencionados en instrucciones, no la acción.

6.- Perfil ocupacional

6.1.-Exploracion y sentido de autoeficacia:

A nivel de exploración, al organizar el ambiente para su exploración Cristian logra observar, manipular objetos con indicios del adulto manteniéndose por algunos minutos con objetos aleatorios. Cabe mencionar que tiende a buscar objetos de interés dentro de los espacios. **A nivel de sentido de autoeficacia**, Cristian logra participar en actividades de su espertis, buscando la mirada del adulto para la aprobación y/o continuar con el siguiente paso. Se siguen observan algunos desafíos para lograr

6.2.- A nivel de habituación:

Cristian participa de forma activa en rutinas de la vida diaria básicas donde también necesita de un modelado inicial para lograr objetivos de forma independiente. Cabe mencionar que potencia la realización de tareas para un objetivo, donde necesita de supervisión para cumplir con cada una de ellas.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados mediante observaciones, los instrumentos fonoaudiológicos aplicados, los criterios diagnósticos de Susanibar, es posible señalar que Cristian presenta un Trastorno de los **Sonidos del Habla (TSH) fonético**, con **etiología neuromotora** debido a la Apraxia del Habla Infantil que presenta. He de destacar que Cristian al presentar una **Apraxia del Habla Infantil (AHI)** le dificulta la planificación, programación de los movimientos y producción de los sonidos del habla.

En segundo lugar, considerando la evaluación y observación de los aspectos comunicativos - lingüísticos de Cristian, es posible señalar que presenta un **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) segundario al Trastorno del Espectro Autista** lo que genera dificultad para la expresión y comprensión de más de un área en el lenguaje.

Desde el área de Terapia ocupacional se puede establecer que Cristian presenta **desafíos sensoriomotores** que impactan en la consolidación y entrenamiento de habilidades cognitivas, donde **necesita de supervisión y apoyo ocasional** para lograr objetivos. Cabe mencionar que lo anterior interfiere en el desempeño de las ocupaciones de AVDB, JUEGO, EDUCACION e INTERACCIÓN SOCIAL.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere incorporar en la rutina de Cristian “ejercicios/actividades” enviadas desde fonoaudiología para seguir potenciando habilidades necesarias en Apraxia del Habla Infantil.
- Se sugiere la adquisición de utensilios (cuchara/tenedor) con mango engrosado para mayor precisión en espacios de alimentación. Por medio de planner mensual se enviará lugares de compra e imagen referencial.

Al establecimiento:

- Se sugiere seguir potenciando la comunicación no verbal y comprensión a través de Proloquo2go según indiquen actividades académicas.
- Se sugiere mantener espacios estructurados para mayor habituación a los espacios de demanda tanto cognitiva como social, lo cual debe se sistematizado de forma diaria.
- Continuar con la comunicación directa con profesiones clínicos para el abordaje de eventualidades y anticipación a actividades realizas dentro del establecimiento.
- Se sugiere el envió de planificación de objetivos según curriculum actual de Cristian para el su refuerzo en espacios clínicos.

Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Coordinadora Sede Santiago
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA

Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA

Valeska Ananías Gómez
Directora Clinica
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago. Febrero 2026